Meeting Intelligence Report

Meeting Date: 26/06/2026, 10:08:00

Client: Unidade Saúde Cova da Beira

EXECUTIVE SUMMARY

A reunião focou-se na implementação de um projeto de excelência no atendimento para uma entidade pública, visando colmatar deficiências históricas no serviço prestado. O projeto, dividido em quatro fases (observação inicial, cliente mistério, formação e consolidação), tem como objetivo transformar o comportamento dos profissionais, garantindo uma abordagem mais eficaz e cuidada ao público. Identificou-se que as entidades públicas frequentemente apresentam um atendimento deficitário devido à falta de recursos adequados, estruturas e formação especializada. Atualmente, a formação de novos colaboradores é frequentemente informal, realizada pelos próprios colegas, o que é considerado inadequado. O projeto propõe a contratação de um fornecedor externo especializado para desenvolver uma formação abrangente que cubra a qualidade do serviço, a imagem profissional, a gestão de emoções, a linguagem utilizada e a comunicação em diferentes canais (telefónico e presencial). A primeira fase da formação, com início previsto para julho, terá como foco o grupo de gestores do utente do hospital, especialmente no que diz respeito à consulta médica telefónica. Serão formados cinco grupos de 14 pessoas, totalizando 70 participantes. A formação terá a duração de 14 horas, com flexibilidade no planeamento dos horários para se adaptar às necessidades operacionais. Foram discutidas a importância de uma avaliação formativa (testes finais) e qualitativa (relatórios do formador) para medir a eficácia da formação. Salientou-se a necessidade de os formadores terem conhecimentos específicos na área da saúde para abordar temas sensíveis como a comunicação de más notícias, garantindo a relevância e adequação do conteúdo.

KEY HIGHLIGHTS

1. Deficiência Histórica no Atendimento Público: As entidades públicas são historicamente deficitárias na formação dos seus profissionais de atendimento ao público, devido à falta de recursos e estruturas que prevejam esta necessidade.

2. Formação Interna Insuficiente: A formação de novos colaboradores é frequentemente feita por colegas, sem um guião ou estrutura adequada, o que resulta num atendimento inconsistente e ineficaz.

3. Necessidade de Especialização Externa: Há uma clara necessidade de um fornecedor externo especializado em atendimento ao público para desenvolver e implementar formações que garantam uma transformação comportamental.

4. Estrutura do Projeto: O projeto compreende quatro fases: observação inicial no posto de trabalho, realização de cliente mistério, formação e uma fase de consolidação com duas a quatro visitas de acompanhamento.

5. Foco Inicial no Atendimento Telefónico: O primeiro grupo a ser formado será o dos gestores do utente do hospital, com especial ênfase na comunicação telefónica, dadas as suas especificidades.

6. Total de Participantes: Serão formados cinco grupos de 14 pessoas, totalizando 70 profissionais.

7. Abordagem Prática na Formação: As formações não serão meramente expositivas, incluindo role-plays, simulações e a utilização de exemplos práticos, ajustados ao contexto específico de cada canal de comunicação.

8. Importância do Contexto de Saúde: É crucial que os formadores tenham conhecimento da área da saúde, dada a sensibilidade dos dados e a natureza das interações, como a comunicação de notícias difíceis.

NEXT ACTIONS

[ ] Bruno: Verificar a disponibilidade dos formadores para iniciar o projeto em julho.

[ ] Bruno: Falar com a área pedagógica para identificar os formadores mais adequados e partilhar os seus currículos com a equipa.

[ ] Bruno: Agendar uma reunião de preparação com a área pedagógica e o formador para alinhar os exercícios, adaptar as dinâmicas ao público-alvo e assegurar a relevância dos exemplos práticos.

[ ] Bruno: Recolher toda a informação necessária e, se for o caso, direcionar questões adicionais para Nelson.

[ ] Bruno: Fornecer um ponto de situação na segunda ou terça-feira seguinte com a informação recolhida.

[ ] Nelson: Construir os grupos de 14 pessoas, tendo em conta o planeamento das férias dos colaboradores.

[ ] Nelson: Passar os contactos dos profissionais do gestor do utente a Bruno para a realização das sessões de cliente mistério.

[ ] Nelson: Fornecer a Bruno o conteúdo funcional sobre o que os assistentes técnicos podem ou não podem fazer.

[ ] Equipa (Bruno, Nelson, Sandra): Identificar quaisquer outras indicações relevantes para o projeto e comunicá-las a Bruno (com conhecimento da Zélia).

FULL TRANSCRIPT

[00:00] SPEAKER A
Bom dia.

[00:04] SPEAKER B
Bom dia, João, como está? Tudo bem?

[00:06] SPEAKER A

Bem, bem. Viva.

[00:07] SPEAKER C
Ótimo, bem-disposto.

[00:09] SPEAKER B
Nelson.

[00:11] SPEAKER A
Olá, Professor, bom dia.

[00:15] SPEAKER C
Olá, Nelson.

[00:15] SPEAKER A
Ah, devíamos estar aqui, devíamos ter a Doutora Sandra também. Doutora Sandra?

[00:20] SPEAKER D
Assim.

[00:22] SPEAKER A
OK, vou ver se ela entra.

[00:33] SPEAKER C
Eu vou sair e vou voltar a entrar, pronto. OK, como é que se ligava a câmara, Doutora?

[00:36] SPEAKER A
OK, OK, Nelson.

[01:27] SPEAKER C
Pronto. Eu não consigo mesmo ligar a câmara, peço desculpa.

[01:31] SPEAKER A
Sem problema.

[01:38] SPEAKER A
OK.

[01:39] SPEAKER B
Muito bem.

[01:43] SPEAKER A
Temos aqui já a Doutora Sandra também.

[01:50] SPEAKER A

Então, podemos começar?

[01:51] SPEAKER B

Claro que sim. Professor, antes de mais, só dar-vos aqui o contexto, porque a Zélia está ausente, regressa na próxima semana. Ah, portanto, irei fazer aqui esta primeira ponte, OK? Ah, eu tinha dito ontem ao Nelson que iria tentar ter um dos nossos formadores, ou algum colega da área pedagógica presente, mas não foi possível. Portanto, irei recolher toda a informação que vocês considerarem necessária e, se for necessário, depois mais alguns esclarecimentos, voltamos ao contacto, está bem?

[02:30] SPEAKER A

Está sem som, Professor.

[02:32] SPEAKER A

Qual é o ponto da situação? Qual é a proposta, em que ponto é que nós estamos, basicamente? Ah, esta era a minha primeira pergunta.

[02:40] SPEAKER B

OK. Tenho indicação de que a Zélia vos enviou a proposta, certo? Tanto financeira como de conteúdos. Ah, e portanto, o que tenho aqui para este projeto de excelência no atendimento é um projeto que está dividido em quatro fases: uma observação de "on the job" inicial, depois a realização do cliente mistério, a formação propriamente dita e, no final, uma fase de consolidação com mais duas a quatro visitas para cliente mistério, certo? Não sei se é esta, ah, ah.

[03:14] SPEAKER B

Pronto. A indicação que tenho é que, da vossa parte, pretendem avançar com este projeto. Agora, queria perceber do vosso lado também mais algum enquadramento para que eu possa passar à formadora e à área pedagógica e para garantir que todas estas fases vão ao encontro do pretendido, mas gostaria de ouvir um pouco da vossa parte. Sei que já partilharam com a Zélia o que vos levou a fazer este investimento, a apostar nesta área, mas se me puderem dar esse contexto, agradecia.

[03:50] SPEAKER A

O contexto é o seguinte. Somos uma entidade pública e, historicamente, as entidades públicas, no que diz respeito aos atendimentos, são deficitárias no que se refere à formação dos profissionais, geralmente dos profissionais administrativos, no atendimento ao público.

[04:20] SPEAKER A

Hum, hum.

[04:22] SPEAKER A

Pronto. E são deficitárias logo à partida porque os recursos e as estruturas destas organizações muitas vezes não preveem isto desta maneira.

[04:37] SPEAKER A

Pronto, não preveem. Não temos gente para fazer esse acompanhamento necessariamente, ou sequer para ter. Nunca tiveram este tipo de formação.

[04:47] SPEAKER A

Outro dia dizia-me alguém, por exemplo, que, bom, para nós fazermos o... quando aparece um novo funcionário, um novo colaborador, são os colegas que lhe dão a formação. Isto dizia-me uma colega.

[05:02] SPEAKER A

Pá, isso é errado. Na estrutura, quem deve dar a formação tem de haver um guião, todo um protocolo sobre como falar, como dizer, qual é o protocolo a seguir, pronto, e claramente não é feito.

[05:21] SPEAKER A

Nós temos tentado agora imprimir, paulatinamente, nos vários serviços, uma maneira de agir diferente. E aquilo de que precisávamos era, de facto, que houvesse um fornecedor externo que estivesse especializado no atendimento ao público para que pudéssemos dar uma formação e garantir uma transformação no comportamento, designadamente do front office, o que é absolutamente essencial. Porque posso ter um médico e, seguramente, profissionais clínicos a prestar bons cuidados de saúde, e tenho-os. Só que, depois, a experiência do doente, se ela for péssima em tudo aquilo que for não clínico, o SNS... a perceção que as pessoas têm do SNS é que é uma organização que já não sabe o que faz e que cada um está a fazer o que lhe apetece para o seu lado.

[06:33] SPEAKER A

Se nós pensarmos que os médicos do SNS e do privado são os mesmos, o problema não está nos médicos.

[06:42] SPEAKER B

Certo. Certo.

[06:45] SPEAKER A

E, portanto, precisamos, de facto, de alguém que tenha, ou de uma empresa que nos ajude, que tenha essa experiência. Não é a coisa da administração, pelo menos, não é assim que vejo o papel do conselho de administração, que é agora saber tudo sobre a maneira de atender clientes. Naturalmente, todos nós temos ideias sobre o que é um bom atendimento e o que é um mau atendimento. Mas precisamos que isto seja feito por quem tenha experiência, quem tenha isto bem montado, com base em experiência, em ciência e em resultados depois medidos ao longo dos anos de existência da própria organização.

[07:22] SPEAKER A

Pronto, sim, este é o contexto.

[07:25] SPEAKER B

Muito bem. Então, deixar-vos só aqui nota. Professor, esta realidade que está a identificar, e como disse muito bem, obviamente, não é única da vossa unidade local. Nós já temos trabalhado com outras no mesmo contexto, inclusive, como referiu, e também muito bem, a questão da diferença entre aquilo que vocês fazem e uma unidade de saúde privada. Muitas das vezes, o que difere é mesmo esta questão do atendimento e nós temos trabalhado também já no passado com outros grupos empresariais privados na área da saúde que tiveram esta preocupação, igualmente, porque identificaram que coisas muito práticas como a qualidade do serviço, a imagem profissional que o próprio profissional passa para o paciente, a gestão das emoções durante uma interação com um cliente, as primeiras impressões que são dadas, a linguagem, o tipo de linguagem que é utilizada, mais positiva, mais direcionada para aquilo que é a resolução do porquê de o paciente lá estar. Portanto, tudo isto são temas que são trabalhados nesta área de excelência de atendimento e que nós temos trabalhado e, portanto, temos perfeita noção de que esse é o ponto de viragem, porque os profissionais que vocês têm são qualificados, a experiência está lá, a perceção, lá está, é que muitas das vezes pode não ser aquela. E muitas das vezes os processos já existem, é mesmo uma questão de... nós aqui estamos a falar sempre de mudança de comportamentos, não é? E os comportamentos não se mudam só porque nós queremos. Os comportamentos mudam-se com conhecimento, com informação, com reforço e com a aplicabilidade daquilo que depois é aprendido nas formações, pronto.

[09:17] SPEAKER B

Isto em termos do que temos e podemos fazer. Em termos de estrutura, a estrutura que apresentámos com esta divisão em quatro fases, faz-vos sentido? Ou seja, termos uma observação inicial, depois termos aqui algumas sessões de cliente mistério e, aí sim, depois com essa informação, passar para a formação? Faz-vos sentido esta estrutura?

[09:42] SPEAKER C

Sim.

[09:43] SPEAKER C

Essa estrutura já tinha sido adaptada ao modelo que queríamos usar, portanto.

[09:48] SPEAKER A

OK, muito bem. Boa. Pronto.

[09:50] SPEAKER B

Então, da nossa parte, o que é importante para nós percebermos? Em termos logísticos e de timings, quando gostariam de começar? Em termos de local de formação, em termos de espaço para formação, não sei se me podem dar um pouco essa informação, se já têm tudo pensado, qual era a vossa ideia?

[10:12] SPEAKER A

Nós estamos a falar de quantas pessoas? Lembrem-me lá, que eu não tenho isso presente.

[10:16] SPEAKER C

São cinco grupos de 14 pessoas, Professor João.

[10:20] SPEAKER A

E estamos a falar só do hospital para começar? Ou estamos a falar também dos centros de saúde?

[10:24] SPEAKER D

Sim, para... eu não tenho câmara, peço imensa desculpa, mas já entrei, saí, entrei, saí, e há aqui algum problema.

[10:31] SPEAKER A

Havia um problema de rede, sim.

[10:34] SPEAKER D

Pronto. Acho que sim, que para começar seria só com o hospital e eu até sugeria, Nelson, que começássemos também pelo gestor do utente.

[10:45] SPEAKER C

Sim, sim, sim, sim, sim.

[10:46] SPEAKER D

Do atendimento, pelo contacto telefónico do gestor do utente. E é premente iniciar.

[10:54] SPEAKER D

Já.

[10:55] SPEAKER A

OK.

[10:56] SPEAKER B

Pronto. Quando diz 'já', a seguir a esta conversa, o que vamos fazer é verificar quem são os formadores disponíveis e qual a sua disponibilidade. Faz sentido apontarmos agora para este período antes das férias, ou preferem apontar para setembro? Qual é a vossa preferência?

[11:20] SPEAKER D

Para mim faz sentido iniciar já. Nem toda a gente está de férias em simultâneo. Faz sentido iniciar já, não sei qual é a opinião do Presidente e do Nelson.

[11:30] SPEAKER A

Eu concordo.

[11:30] SPEAKER C

Eu concordo, sim.

[11:32] SPEAKER A

OK. É isso.

[11:33] SPEAKER C

São cinco grupos de 14 pessoas, é isso. Quem está de férias, está de férias, quem não está de férias pode iniciar, concordamos.

[11:39] SPEAKER A

OK. Pronto. Muito bem.

[11:41] SPEAKER B

Então, ainda em termos desta parte mais logística. Vou ver a disponibilidade de formadores. Em termos de local de formação, qual é o local desta primeira turma?

[11:55] SPEAKER C
Perdão. O local, perdão.

[11:57] SPEAKER A
Sim, exatamente.

[11:58] SPEAKER C
Já está previsto na proposta, Bruno, que seja cá no hospital. No hospital.

[12:03] SPEAKER A
No hospital. OK, pronto.

[12:05] SPEAKER B
Muito bem.

[12:08] SPEAKER A
Dentro destes temas e de acordo com o programa que foi partilhado, Nelson, algum tema que considerem mais premente? Não sei se querem revisitar o programa para podermos focar algum tema.

[12:28] SPEAKER D
Talvez.

[12:29] SPEAKER A
OK, então, se me permitirem, partilho convosco.

[12:39] SPEAKER D
Vocês têm formadores, provavelmente, mais vocacionados, mais integrados na área da saúde, certo?

[12:48] SPEAKER B
Nós temos formadores não só especialistas no tema em si que vai ser dado, ou seja, nestes temas de atendimento, comunicação, área comportamental, os temas que vão ser mencionados, mas também muitos destes, alguns deles, consoante o tema, podem ser profissionais ou profissionais de saúde, se for numa área comportamental, com formação em psicologia, por exemplo. Ou então são profissionais, por norma, aquilo que tentamos fazer é colocar profissionais que já tenham tido as mesmas formações num ambiente idêntico ao vosso, OK?

[13:22] SPEAKER A
Certo.

[13:23] SPEAKER D

Era isso que pedíamos, sim, porque os dados de saúde também vão abordar questões de dados de saúde, são dados sensíveis e não podem ser divulgados, nomeadamente, aquilo de que estava a falar sobre o gestor do utente. E, portanto, convém que o formador também tenha alguma afinidade com esse assunto e com esse tema. E não fale de um modo geral do atendimento. Porque o atendimento no hospital é diferente do atendimento nas finanças, como é evidente. Portanto, tem de haver uma sensibilidade diferente porque os dados também são diferentes, não é?

[13:56] SPEAKER B

Sim, sem dúvida. Isso teremos sempre em atenção, como disse bem. Uma formação de atendimento nas finanças ou numa área industrial ou numa empresa de serviço é completamente diferente. As preocupações, o tipo... até porque aqui estamos a falar de um atendimento a um cliente, digamos assim, que é um cliente que, muitas das vezes, já vem sob stresse, sob pressão, e, portanto, são abordagens completamente diferentes. Sim, sem dúvida. Vou partilhar então aqui o programa.

[14:27] SPEAKER C

No seguimento daquilo que a Doutora Sandra disse, eu sugeria nesta fase, num projeto novo que também temos na ULS, que é a consulta médica telefónica, que este primeiro grupo podia ser o gestor do utente e os elementos que integram esta equipa, que tem muito contacto telefónico. Queríamos reforçar a comunicação que é passada aos utentes e aquilo que podemos e não podemos dizer. E a forma como respondemos às questões que o doente coloca.

[15:00] SPEAKER A

OK. Pronto, portanto este primeiro grupo terá muito foco na principal ferramenta de trabalho deles, que é o atendimento telefónico. Sim. OK.

[15:09] SPEAKER A

Algum destes tem também atendimento presencial ou é só telefónico?

[15:14] SPEAKER C

Este é tudo telefónico.

[15:16] SPEAKER A

Só telefónico, OK.

[15:17] SPEAKER C

Este grupo é tudo telefónico, sim.

[15:19] SPEAKER A

Mas também nesta lógica, eu não sei quem são os 14. Cinco vezes 14 dá 70 pessoas, que eu tive ali a fazer as contas. Nesta lógica também podia ser interessante... bom, mas começamos por aqui, acho bem. Tudo bem, está certo.

[15:34] SPEAKER A

OK.

[15:35] SPEAKER B

Pronto, há temas e módulos, obviamente, muito transversais, independentemente do tipo de atendimento que eles tenham, não é? Tudo o que é relacionado com as necessidades do cliente, a gestão das emoções, o diagnóstico, a linguagem. Agora, a única coisa que vai mudar depois é o canal. O que quero dizer com isto? Em termos de aplicabilidade prática, as nossas formações não são meramente expositivas. Temos muitos role-plays, muitas simulações. E todos os exemplos e exercícios que forem dados vão ser sempre direcionados consoante o canal de comunicação mais utilizado, seja escrito, por telefone ou presencial, porque sabemos que, por exemplo, uma comunicação não verbal ao telefone é difícil de ser detetada. Portanto, há determinadas coisas que têm de ser ajustadas nos exercícios que se fazem. Este foi o programa a que vocês tiveram acesso, correto?

[16:32] SPEAKER A

Sim.

[16:33] SPEAKER A

OK. Pronto.

[16:34] SPEAKER B

Portanto, como lhe disse, há temas que são totalmente transversais. A única coisa que vai mudar será depois o foco, consoante o grupo, nas técnicas específicas de atendimento, seja por telefone ou presencial. É a única coisa que vai alterar, está bem? Os exercícios que vão ser feitos. O que vai acontecer também? Antes de avançarmos com a ação de formação, vai ser importante termos uma reunião de preparação com a nossa área pedagógica e com o formador para poder alinhar os exercícios que são feitos. E digo isto porquê? Porque há determinadas dinâmicas que são implementadas nas formações que têm de ser práticas, mas que têm de ser ajustadas às pessoas. E vocês é que conhecem as pessoas que vão lá estar e também nos saberão dizer se faz sentido ou não ter esta ou aquela dinâmica consoante aquele público-alvo, está bem? Portanto, tudo isso é assegurado para que, quando o formador chegar à sala, primeiro, as pessoas já estejam familiarizadas e saibam aquilo que vão e que tenham uma experiência o mais real possível do seu dia-a-dia e que se identifiquem com ela. Pronto.

[17:42] SPEAKER B

Em termos de programa, há algum tópico, além desta questão do atendimento, a que seja mais importante dar foco?

[17:51] SPEAKER A

Não, quer dizer, a experiência é esta. Nós queremos que as pessoas saibam comportar-se. Basicamente é isto. Não ter um atendimento, pá, de uma a cinco estrelas. Quando chegamos a um determinado lugar, pedimos, enfim, vamos ao balcão e a pessoa... Queremos que saiba responder, saiba comportar-se, saiba estar. Neste caso, vamos também avançar com uniformes e, portanto, que tenham um uniforme devidamente cuidado. Que não haja coisas como 'Voltaste para trás, ó Maria!', 'Tu não sei quê', pá, pronto, que seja uma coisa cuidada. Eu, aqui, voltando ao número, às pessoas... como não estou a acompanhar isto de todo, não tenho presente estes 70 pessoas. Concordo com o hospital, naturalmente, concordo com o gestor do utente, também concordo com a consulta médica telefónica. Concordo com tudo isto. Mas seria interessante fazer um levantamento exato de quais são as pessoas, Nelson, nessas 70 pessoas, porque se houvesse espaço, eu podia também as sedes, pelo menos as sedes dos cuidados primários. E, portanto, das cinco, sendo possível. Sendo que, como o Nelson sabe, não é, temos algumas dificuldades em algumas delas, que nos obrigou até a fazer algumas trocas. Pronto, portanto, como opcional, não é? Mas seria importante fazer esse levantamento, saber quando as pessoas estão de férias e não estão de férias e, portanto, juntar estes grupos.

[19:38] SPEAKER C

Era isso que eu ia sugerir. Ia construir os grupos de 14 pessoas, com a planificação das férias existentes. E depois também já é mais fácil para nos conseguirmos organizar.

[19:48] SPEAKER A

OK. Nelson, só deixar-vos a indicação: obviamente que nós sugerimos 14 pessoas, mas se tiverem mais uma ou duas pessoas que seja necessário integrar o grupo, não há problema nenhum, está bem? Não vamos deixá-las de fora por causa disso, pronto. Porque, às vezes, se tivermos mais dois ou três elementos que faça sentido estarem naquele grupo, pode-se fazê-lo.

[20:08] SPEAKER A

OK.

[20:09] SPEAKER C

Obrigado.

[20:11] SPEAKER B

Então, o que sugiro... (deixem-me só para vos poder ver novamente). O que sugiro é que vou falar com a nossa área pedagógica e vamos identificar o ou os, ou as formadoras que poderão estar associadas a este projeto. Vamos partilhar convosco também as notas curriculares destas pessoas para vocês verem. E diria que seria importante marcar uma ou outra conversa mais à frente. Ou seja, vamos partilhar também as disponibilidades e marcar depois uma conversa para prepararmos alguma questão mais logística que tenham, alguma dúvida que possam ter na construção das turmas, alguma sugestão que seja necessária. Podemos fazê-lo diretamente já com o formador para vocês o conhecerem também e para alinhar tudo, está bem?

[20:55] SPEAKER A

OK. Um outro aspeto, naturalmente, Nelson, é fazer de modo a que o hospital continue a trabalhar, não é? O hospital, sim.

[21:05] SPEAKER B

Aqui estamos a falar de formação, são 14 horas cada. Deixem-me só ver. Só para ter a certeza. Portanto, estamos a falar de 14 horas. O que podemos fazer? Não têm de ser 14 horas seguidas, OK? Se eventualmente conseguirmos ter dois grupos, por exemplo, numa semana, podemos fazer um grupo na parte da manhã e outro grupo na parte da tarde, meios dias. E assim, temos sempre pessoas alocadas, claro, claro. Não tem de ser nem dois dias seguidos. Pode ser também, se quiserem um dia completo, pode ser um dia numa semana, outro dia na semana seguinte. O que sugerimos é que não haja uma distância muito grande entre cada sessão para que não se perca aquilo que também está a ser assimilado na formação.

[21:54] SPEAKER A

Posso sugerir uma coisa ou perguntar, está bem? Tenho o vício de dar aulas, não é? Tenho o vício, enfim, venho com este viés de dar aulas, vamos dizer assim. E é muito fácil que as pessoas, claro, vão para a formação e na formação vão sempre beneficiar de alguma coisa. Mas gostaria que houvesse um teste no fim.

[22:17] SPEAKER B

OK.

[22:19] SPEAKER A

Para saber se elas estão aptas ou não. E nós diríamos às nossas pessoas, não sei, Nelson e Sandra, não faço ideia como é que isto se pode fazer, mas em termos de avaliação, seria passar neste teste para se ser considerado apto, pudesse ser.

[22:40] SPEAKER D

Concordo com o teste. Devemos ver como conseguimos articular com a avaliação de aptidão, mas concordo com o teste. E...

[22:49] SPEAKER C

É essencial que haja aptos. Um dos objetivos já é a qualidade do atendimento e o cumprimento do atendimento de excelência, portanto, pode ser incluído aqui neste campo.

[23:00] SPEAKER B

OK.

[23:01] SPEAKER A

Uma demonstração é passar o teste, não é? Dizer, em princípio.

[23:05] SPEAKER D

Mas isso reforça a ideia de que os formadores, ou quem elaborar o teste, tem de ter conhecimento na área da saúde. Porque estava a ver ali uma das questões, um dos temas a abordar: como dar más notícias. Há a ideia de que o administrativo, o assistente técnico do hospital, pode telefonar para casa e dizer assim: 'Olha, o seu familiar faleceu!' Isso não é verdade, isso não é permitido. Portanto, a pessoa que for dar formação, que elaborar o teste, tem de ter consciência disso. Não vá falar, como disseram, as pessoas ficam baralhadas porque não é um administrativo que dá más notícias, isso não pode ser. E dados clínicos, eles não divulgam. Portanto, o formador tem de ter conhecimentos na área da saúde. Não pode ser um tema qualquer.

[23:54] SPEAKER C

Eu posso dar-lhe o conteúdo funcional, Bruno, depois, o que a equipa de assistentes técnicos pode e não pode fazer. Portanto, depois...

[24:02] SPEAKER A

Isso leva a uma outra questão, que é um excelente ponto aqui da Doutora Sandra. Leva a um excelente ponto e que, naturalmente, a responsabilidade do teste é vossa, mas ele, antes de ser administrado, tem de ser sancionado pelo Conselho de Administração.

[24:16] SPEAKER B

OK. Sim, isso faremos sempre, faremos sempre essa partilha convosco para medir. Obviamente, temos a escala e temos os temas que vão ser avaliados, mas partilhamos convosco para vocês darem o aval antes. Além deste teste, no final de qualquer ação de formação, fazemos sempre dois tipos de avaliação. Portanto, fazemos a avaliação típica da satisfação — se correu bem, se não correu, se gostaram, se o formador cumpriu — mas também fazemos uma avaliação de nível dois em que não é propriamente uma avaliação quantitativa como este teste que vocês propõem, mas sim uma avaliação mais qualitativa. Ou seja, é um relatório que o próprio formador faz da observação, que diz: 'Nós começámos neste ponto, trabalhámos estes temas e acabámos aqui.' E determinados recursos ou profissionais revelaram mais ou menos propensão ou mais afinidade com a comunicação presencial, ou mais afinidade na passagem de notícias. E aqui, quando falamos de passagem de notícias menos boas, às vezes, não é necessariamente esse exemplo que deu, Doutora Sandra. Pode ser coisas simples como: 'Olhem, tivemos que desmarcar a consulta' ou 'Houve aqui uma alteração'. Muitas das vezes sabemos que tem impacto também na própria pessoa. Portanto, esse tipo de exemplos são sempre assegurados, por isso é que vos disse há pouco que a reunião de preparação é muito importante para assegurar esses exemplos que podem ou não ser dados e que vocês querem ou não incluir. Inclusive, se tiverem alguma situação real que tenha acontecido, que queiram transpor como caso prático para a formação, também podemos fazê-lo, OK? De forma mascarada, para que ninguém se sinta, obviamente, visado com aquilo que está a ser dado ou: 'Este exemplo aconteceu comigo e por isso é que estão a trabalhar este ponto'. Não, podemos transformá-lo para o dar na formação.

[26:11] SPEAKER A

OK.

[26:12] SPEAKER A

Sim, muitas situações vai haver, quer dizer, estou a pensar, não é? Isso na urgência, consultas, qualquer sítio, não é? Exatamente.

[26:24] SPEAKER B

Exatamente. E depois, não só a situação é importante trabalhá-la, mas também os próprios perfis de quem está perante essa situação também são diferentes, não é? Portanto, também é importante, às vezes, termos a noção de que o perfil do meu par, que trabalha comigo, aborda a situação de uma maneira diferente, que eu posso ir buscar algo ou não, ou que não devo ir buscar e, portanto, todos esses exemplos são ajustados e trabalhados.

[26:51] SPEAKER B

Pronto. Então, próximos passos. Vou ver a disponibilidade de formadores para começarem este projeto em julho. O primeiro grupo prioritário, portanto, é o grupo da gestão do utente. No...

[27:05] SPEAKER A

Bruno, se calhar, ia-lhe passar, como temos a parte do cliente mistério e como este primeiro grupo trabalha muito a nível do telefone, iria-lhe passar os contactos para fazer o cliente mistério a estes profissionais. E aquilo que, no caso da consulta médica telefónica, existe um guião. Portanto, nós já fazemos cliente mistério a esta equipa, mas também seria bom vocês fazerem, para verem o que é necessário melhorar.

[27:37] SPEAKER B

OK, perfeito. Perfeito.

[27:39] SPEAKER B

Pronto, vou recolher esta informação. Se eventualmente houver mais algum ponto que a nossa equipa pedagógica necessite, posso direcionar para si, Nelson?

[27:48] SPEAKER C

Sim, sim, sim. OK.

[27:50] SPEAKER B

Pronto. E conto, na segunda ou terça-feira, já ter alguma informação para vos dar, está bem?

[27:58] SPEAKER A

OK.

[27:59] SPEAKER B

Pronto. Eventualmente, se houver alguma outra indicação que se lembrem, que seja necessário juntar, estejam à vontade. Podem reencaminhar para mim, com o conhecimento da Zélia. Um de nós vai dar seguimento, está bem?

[28:12] SPEAKER C

OK.

[28:13] SPEAKER D

Obrigada.

[28:14] SPEAKER A

Muito obrigado.

[28:15] SPEAKER C

Muito obrigado.

[28:15] SPEAKER A

João, Doutora Sandra, muito gosto. Bom fim de semana a todos.

[28:18] SPEAKER C

Obrigado. Muito obrigado.

[28:19] SPEAKER A

Obrigado.